HELP_Organi_P13 — Groupe C — Lots 232 à 236 — 16 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 13 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

C-020 — Haute — LOT 233 · SSP O7.11

Emplacement : LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) › 🔍 Fenêtre Interactive 11.B.2 : médicaments (classe, DCI, spécialité su (lacune #71)

Contexte : Le cours cite le pentobarbital sodique pour l'assistance au suicide (stupéfiant, prescription par un médecin, annonce cantonale dans les 30 jours) sans spécialité ni dose.

Question : Quel est le statut suisse du pentobarbital sodique (spécialité autorisée ou préparation magistrale, catégorie de stupéfiant selon l'OStup), quelles règles de prescription et d'annonce s'appliquent, et quelle dose la pratique suisse documentée emploie-t-elle ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-023 — Haute — LOT 233 · SSP O7.11

Emplacement : LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) › grève de la faim (lacune #112) ; LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) (lacune #113) ; LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) (lacune #114) ; LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) › Situation de jeûne sec (lacune #115)

Contexte : Le cours traite la grève de la faim en détention (> 90 % s'arrêtent en moins d'une semaine ; Genève 1,3 % au début des années 1990 ; directive ASSM « Exercice de la médecine auprès de personnes détenues ») ; le délai de survie du jeûne sec et les seuils de surveillance ne sont pas chiffrés.

Question : Quelle est la version en vigueur de la directive ASSM sur la médecine auprès des personnes détenues et que prescrit-elle pour la grève de la faim ? Quels seuils de surveillance (perte de poids, IMC, signes vitaux, rythme des contrôles) et quels délais de risque vital pour le jeûne hydrique et le jeûne sec retiennent les sources européennes (déclaration de Malte AMM 2017, CICR) ? Existe-t-il des données suisses récentes ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-024 — Haute — LOT 233 · SSP O7.11

Emplacement : LOT_233_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › LOT 233 Plan et Liste › 7.9. Femme enceinte qui refuse (DX.9) (lacune #11) ; LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) › NURSE (lacune #107)

Contexte : Le cours écrit qu'aucune recommandation suisse ou européenne n'existe sur le refus de césarienne par une femme capable (cas fictif 34 ans, 39 SA) ; les paramètres obstétricaux et fœtaux de l'examen ne sont pas donnés.

Question : Existe-t-il un avis d'experts de la SSGO/gynécologie suisse, une prise de position de l'ASSM, du RCOG, du CNGOF ou de la FIGO sur le refus de césarienne ou de traitement pendant la grossesse ? Quelle conduite, quelle documentation et quels paramètres de surveillance maternelle et fœtale recommandent-ils ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-025 — Haute — LOT 233 · SSP O7.11

Emplacement : LOT_233_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html ;

LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › LOT 233 Plan et Liste › VIII.B. Moyens › mécanisme (lacune #13) ; LOT 233 Partie 3 DX.6 a DX.7 › époétine alfa (lacune #86) ; LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) › acide tranexamique (lacune #110)

Contexte : Le cours donne Eprex® (époétine alfa) : chirurgie orthopédique majeure, Hb 100–130 g/L, 600 UI/kg s.c. à J−21, J−14, J−7 et J0, arrêt si Hb ≥ 150 g/L ; adaptations rénale et hépatique, indication obstétricale et pédiatrique inconnues.

Question : Que dit l'information professionnelle suisse actuelle d'Eprex® et des autres époétines sur l'adaptation rénale et hépatique, l'enfant, la grossesse et l'usage hors étiquette chez un patient refusant la transfusion ? Quelle recommandation européenne de patient blood management (NATA, ESA) fixe leur usage ? Pour chaque médicament, donne la spécialité suisse, la dose, la voie, la durée et les adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (swissmedicinfo.ch), avec la date de l'IP. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-026 — Haute — LOT 233 · SSP O7.11

Emplacement : LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › LOT 233 Partie 3 DX.6 a DX.7 (lacune #75) ; LOT 233 Partie 3 DX.6 a DX.7 › acide tranexamique (lacune #87) ; LOT 233 Partie 3 DX.6 a DX.7 (lacune #88) ; LOT 233 Partie 3 DX.6 a DX.7 (lacune #89) ; LOT 233 Partie 3 DX.6 a DX.7 › Médicaments du patient blood management chez l'enfant et l'adolescent (lacune #94) ; LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) › acide tranexamique (lacune #109)

Contexte : Pour le patient qui refuse la transfusion, le cours ne donne pas le statut de l'albumine, la durée maximale de l'acide tranexamique, la dose de chlorure de calcium, les doses de B12 et folates associées au fer et à l'érythropoïétine, ni d'alternative au Ferinject® chez l'enfant (non autorisé de 1 à 18 ans selon le cours).

Question : Quelles doses et durées recommandent l'IP suisse et les guides PBM européens pour l'acide tranexamique (durée maximale), le chlorure ou gluconate de calcium (hypocalcémie ionisée en transfusion massive), la vitamine B12 et l'acide folique ? Quel fer intraveineux est autorisé chez l'enfant en Suisse (fer saccharose Venofer®, autres) et à quelle dose ? Quels dérivés sanguins (albumine, facteurs) acceptent ou refusent habituellement les Témoins de Jéhovah selon la littérature européenne ? Pour chaque médicament, donne la spécialité suisse, la dose, la voie, la durée et les adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (swissmedicinfo.ch), avec la date de l'IP. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-027 — Haute — LOT 233 · SSP O7.11

Emplacement : LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › LOT 233 Partie 3 DX.6 a DX.7 › Tableau d'interprétation du bilan d'anémie (lacune #81) ; LOT 233 Partie 3 DX.6 a DX.7 › Tableau d'interprétation du bilan d'anémie (lacune #82) ; LOT 233 Partie 3 DX.6 a DX.7 › Tableau d'interprétation du bilan d'anémie (lacune #83) ; LOT 233 Partie 3 DX.6 a DX.7 (lacune #84) ; LOT 233 Partie 3 DX.6 a DX.7 (lacune #85) ; LOT 233 Partie 3 DX.6 a DX.7 (lacune #90)

Contexte : Le tableau du bilan d'anémie donne des valeurs de référence (ferritine 30–300 µg/L, saturation 16–45 %, folates > 12,2 nmol/L, holoTC > 40 pmol/L) sans seuil de décision ; Ret-He/CHr et B12 totale sans valeur ; fréquence des contrôles d'Hb post-opératoires chez l'enfant inconnue.

Question : Quels seuils de décision recommandent les guides PBM européens et suisses (Swiss PBM, NATA 2024, ESAIC) pour la carence martiale préopératoire (ferritine < 30 ou < 100 µg/L, saturation < 20 %), la B12 totale, le Ret-He/CHr, et quel rythme de contrôle de l'Hb après chirurgie chez l'enfant ou l'adulte refusant la transfusion ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-029 — Haute — LOT 233 · SSP O7.11

Emplacement : LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) (lacune #48)

Contexte : Dans le patient à capacité douteuse, le cours écrit que les doses des psychotropes (antipsychotiques, thymorégulateurs, antidépresseurs) restent introuvables.

Question : Quels psychotropes et quelles doses recommandent les sources suisses (SSPP, Compendium d'urgence psychiatrique HUG/CHUV) pour l'agitation aiguë et le délirium de l'adulte et du sujet âgé (halopéridol, quétiapine, lorazépam, olanzapine), avec contre-indications (coma, QT long, Parkinson) ? Pour chaque médicament, donne la spécialité suisse, la dose, la voie, la durée et les adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (swissmedicinfo.ch), avec la date de l'IP. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-031 — Haute — LOT 233 · SSP O7.11 ; O7.13

Emplacement : LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html ; LOT_235_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) › Culture et test d’amplification (gold standard) (lacune #98) ; LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) › IGRA et

test cutané tuberculinique (lacune #99) ; LOT 235 Plan et Liste › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › [S4] [S6] (lacune #8) ; LOT 235 Plan et Liste › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Test cutané tuberculinique (TCT) (lacune #9) ; LOT 235 Plan et Liste › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Test de libération d'interféron gamma (IGRA) (lacune #10) ; LOT 235 Plan et Liste › Lacunes restantes (lacune #19) ; LOT 235 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › culture mycobactérienne avec antibiogramme (lacune #68) ; LOT 235 Partie 2 DX.3 a DX.5 › Lacunes restantes (lacune #79)

Contexte : Le cours suit le manuel « Tuberculose en Suisse » (Ligue pulmonaire/OFSP) : TCT 0,1 mL PPD RT23 lu à 48–72 h, IGRA non influencé par le BCG, culture et PCR comme référence ; le seuil de positivité de l'IGRA en UI/mL, les seuils du TCT hors enquête d'entourage et les sensibilités/spécificités ne sont pas donnés ; dépistage par entretien dans les 72 h en centre fédéral.

Question : Quelle est la version la plus récente du manuel suisse de la tuberculose et que fixe-t-elle pour le seuil de positivité de l'IGRA (QuantiFERON-TB Gold Plus, T-SPOT.TB), les seuils du TCT selon le contexte, et les sensibilités/spécificités de la microscopie, de la culture, de la PCR (Xpert MTB/RIF) et de l'IGRA ? Quel est le protocole actuel du SEM/OFSP de dépistage de la tuberculose chez les requérants d'asile ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-017 — Moyenne — LOT 233 · SSP O7.11 ; O7.12

Emplacement : LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_234_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › LOT 233 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11, PROFILES 2023) (lacune #29) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) (lacune #46) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) (lacune #49) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) › 🔍 Fenêtre Interactive 9.b.1 : examens de première intention, tableau d (lacune #59) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) › 🔍 Fenêtre Interactive 9.c.1 : grossesse, enfant, rein, imagerie (lacune #60) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) (lacune #62) ; LOT 234 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12) (lacune #46)

Contexte : Le cours renvoie l'imagerie cérébrale d'une cause organique à « des critères non trouvés » et ne traite pas l'allergie aux produits de contraste ni le pacemaker non compatible IRM ; idem pour l'imagerie de la MIP.

Question : Quelles règles européennes ou suisses fixent l'indication du scanner cérébral après traumatisme crânien léger (Canadian CT Head Rule, NICE, Scandinavian guidelines) et chez le patient confus ? Quelle conduite la Société suisse de radiologie recommande-t-elle en cas d'allergie aux produits de contraste iodés (prémédication) et de stimulateur cardiaque (IRM conditionnelle) ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :

2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-028 — Moyenne — LOT 233 · SSP O7.11

Emplacement : LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › LOT 233 Partie 3 DX.6 a DX.7 › Non-discrimination (code de déontologie FMH) (lacune #77) ; LOT 233 Partie 3 DX.6 a DX.7 › ⚖ Fenêtre transversale : Convention d'Oviedo, CEDH 2024 et secret médi (lacune #79)

Contexte : Le cours cite l'arrêt CEDH du 17.9.2024 (requête 15541/20, transfusion contre la volonté d'une patiente, art. 8 et 9) via une revue allemande, sans l'avoir lu ; le nombre de Témoins de Jéhovah en Suisse est inconnu.

Question : Que dit exactement l'arrêt CEDH Pindo Mulla c. Espagne (17.9.2024, requête 15541/20) et quelles conséquences pratiques en tire la doctrine suisse ? Combien de Témoins de Jéhovah compte la Suisse (OFS, communauté) ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-030 — Moyenne — LOT 233 · SSP O7.11

Emplacement : LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) › 🔍 Fenêtre Interactive 11.C.1 : calendrier de surveillance (lacune #61) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) (lacune #63) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) (lacune #64)

Contexte : Pour le patient ivre qui refuse les soins, le cours ne chiffre pas l'intervalle de réévaluation de la capacité après dégrisement et ne cite aucune mesure suisse de prévention.

Question : Quelle recommandation suisse ou européenne fixe la surveillance d'un patient intoxiqué à l'alcool qui refuse les soins (intervalle de réévaluation, critères de sortie, sortie contre avis) ? Quelles mesures nationales de prévention s'appliquent (Stratégie nationale Addictions OFSP, Addiction Suisse) ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-034 — Haute — LOT 234 · SSP O7.12 ; O7.13

Emplacement : LOT_234_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › LOT 234 Plan et Liste › B2.2. Tableau comparatif des dix entités (lacune #4) ; LOT 235 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › injectables à longue durée d'action en PrEP (lacune #96) ; LOT 235 Partie 3 DX.6 a DX.7 › Lacunes restantes (lacune #111)

Contexte : Le cours donne la PEP (dolutégravir 50 mg Tivicay® + emtricitabine/ténofovir disoproxil 30 jours) et la PrEP (Emtricitabin-Tenofovir-Mepha®, 6968 personnes en 2024) ; l'EACS 2025 ajoute la PrEP injectable (cabotégravir, lénacapavir) ; Sunlenca® figure sur la liste Swissmedic mais l'indication PrEP du lénacapavir n'est pas vérifiée.

Question : Quelles spécialités sont autorisées par Swissmedic pour la PrEP VIH en 2026 (génériques emtricitabine/ténofovir disoproxil, Apretude® cabotégravir, lénacapavir Yeztugo®/Sunlenca®), avec indication, schéma et remboursement LS ? Quelles sont les recommandations suisses actuelles de PEP et de PrEP (CFIST/EKSI, OFSP), y compris le schéma à la demande ? Pour chaque médicament, donne la spécialité suisse, la dose, la voie, la durée et les adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (swissmedicinfo.ch), avec la date de l'IP. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-039 — Haute — LOT 234 · SSP O7.12

Emplacement : LOT_234_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_234_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › LOT 234 Plan et Liste › B2.2. Tableau comparatif des dix entités (lacune #7) ; LOT 234 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12 de (lacune #52) ; LOT 234 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12 de › 🔍 Tableau épidémiologique comparé (lacune #53) ; LOT 234 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12 de (lacune #55)

Contexte : Le cours oppose pour la trichomonase le métronidazole 500 mg 2×/j 7 jours (IUSTI) au 2 g dose unique de l'IP (Flagyl®) ; la fréquence suisse de la trichomonase, de la vaginose et de la candidose, l'incubation et la mortalité ne sont pas connues.

Question : Quelle dose et quelle durée de métronidazole fixent l'IP suisse actuelle de Flagyl® et des génériques et la recommandation IUSTI la plus récente pour la trichomonase (femme, homme, grossesse) ? Existe-t-il des données suisses de prévalence de la trichomonase, de la vaginose bactérienne et de la candidose vulvovaginale ? Pour chaque médicament, donne la spécialité suisse, la dose, la voie, la durée et les adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (swissmedicinfo.ch), avec la date de l'IP. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :

6. Certitude et réserves :

C-040 — Haute — LOT 234 · SSP O7.12

Emplacement : LOT_234_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › LOT 234 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12) (lacune #36) ; LOT 234 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12) › méta-analyse bernoise de la prévalence (Baumann et collaborateurs) (lacune #38) ; LOT 234 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12) (lacune #39) ; LOT 234 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12) (lacune #43) ; LOT 234 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12) (lacune #45) ; LOT 234 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12) › pourquoi l'IUSTI déconseille le dépistage des asymptomatiques (lacune #49)

Contexte : Le cours suit l'IUSTI pour M. genitalium (test de résistance aux macrolides, moxifloxacine en 2e intention, 14 jours si infection compliquée, pas de dépistage des asymptomatiques) ; la prévalence suisse, le seuil QTc de contre-indication de la moxifloxacine et l'effet du dépistage ne sont pas donnés.

Question : Quelle est la recommandation européenne la plus récente sur M. genitalium (IUSTI 2021 ou plus récente) et existe-t-il une recommandation suisse (CFIST/OFSP) ? Quels sont les schémas (doxycycline puis azithromycine 1 g puis 500 mg/j, moxifloxacine 400 mg 7 ou 14 jours) et le seuil QTc ou la conduite ECG de l'IP suisse d'Avalox® ? Existe-t-il des données suisses de prévalence et de résistance ? Pour chaque médicament, donne la spécialité suisse, la dose, la voie, la durée et les adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (swissmedicinfo.ch), avec la date de l'IP. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-041 — Haute — LOT 234 · SSP O7.12

Emplacement : LOT_234_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › LOT 234 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (situation de › Doxy-PEP : indication, limites et cadre (lacune #9)

Contexte : Le cours cite la recommandation conditionnelle de la CFIST (EKSI) pour la Doxy-PEP (doxycycline 200 mg dose unique dans les 72 h, HSH et femmes trans avec ≥ 1 IST bactérienne en 12 mois), hors AMM en Suisse.

Question : Quelle est la recommandation suisse actuelle (CFIST/EKSI, OFSP, année, URL) sur la Doxy-PEP, comparée aux positions européennes (ECDC, IUSTI, BASHH 2024) ? Quel est le statut d'autorisation et de remboursement de la doxycycline dans cette indication ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :

6. Certitude et réserves :

C-043 — Haute — LOT 234 · SSP O7.12

Emplacement : LOT_234_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › LOT 234 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12 de (lacune #58) ; LOT 234 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12 de (lacune #59) ; LOT 234 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12 de (lacune #60) ; LOT 234 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12 de › adénopathie (lacune #61) ; LOT 234 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12 de (lacune #63) ; LOT 234 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12 de › 🔍 Traitement symptomatique (lacune #64) ; LOT 234 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12 de (lacune #65)

Contexte : Le cours décrit le mpox (clade IIb depuis 2022, clade Ib en Suisse depuis 2025, déclaration en 24 h) ; le nombre annuel de cas suisses, le statut du técovirimat (absent de la liste Swissmedic du 30.09.2026, importation non vérifiée), le traitement symptomatique et les simulateurs non infectieux ne sont pas donnés.

Question : Combien de cas de mpox l'OFSP a-t-il déclarés par année depuis 2022 ? Le técovirimat est-il disponible en Suisse (importation art. 49 OAMéd, stock de la Pharmacie de l'armée) et selon quelles indications ? Quelle vaccination (Jynneos®/MVA-BN) l'OFSP recommande-t-il en 2026, à qui et selon quel schéma ? Quel traitement symptomatique et quels diagnostics différentiels recommandent l'ECDC ou l'OMS ? Pour chaque médicament, donne la spécialité suisse, la dose, la voie, la durée et les adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (swissmedicinfo.ch), avec la date de l'IP. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P13 — 16 questions : C-020, C-023, C-024, C-025, C-026, C-027, C-029, C-031, C-017, C-028, C-030, C-034, C-039, C-040, C-041, C-043